

IMC - 30.18

MACOMPANHAMENTO () CONSULTA
NS 22231697085 / 745

JURACI ALVES DOS SANTOS

IDADE: 46 PESO: 67 ALTURA: 149 PROFISSÃO: Datilógrafa - Apes.
SINTOMAS: Secreção na garganta (espessa)
QUEIXAS: Sonolência / Desânimo / Esquecida / Tossido
MEDICAMENTOS: Prolopa / Sivarlatina
Parkinson / HAS / Colesterol / Rim (perda de proteína)
MÉDICO: Dr. Gleuco Tupinambá / Dr. Márcio Sérgio
MARCAPASSO: () S (X) N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S (X) N
EXERCÍCIO FÍSICO (X) Píntis Desvio do Septo (E).
HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: 5 ALMOÇO: 5 LANCHE: N JANTAR: 18hs
HORA QUE DORME: 21hs HORA QUE ACORDA: 6hs
COCHILO (X) SIM () NÃO DORME ACOMPANHADO () SIM (X) NÃO () EVENTUAL
BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () X NA SEMANA (X) NÃO
FUMO () SIM () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:
TIPO DE RESPIRAÇÃO: boca BANHEIRO: 3X
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: gorda CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:
OVERLAP: não MALLAMPATI: IAH: 40,7 SPO2: 68%
PATOLOGIAS ASSOCIADAS:
CIRURGIAS: (N) NASAL (S) AMIGDALECTOMIA
HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: rinite
COMORBIDADE: (S) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA
(S) ORTOPÉDICA (S) NEUROLÓGICA () OUTROS Dor mmII.
24/04/24 Teve dificuldade para manter o CPAP durante a PSG c/ titulação.

30/04/24 P= 5.4cmH₂O (mediana) Pas: 7.6cmH₂O

IAH= 1,9 e/h

m. de uso: 7h36m

leak: 6,6 l/m (mediana)

Oriento colocação da máscara e do umidificador no aparelho

Natasha

07/05/24 P= 5,6cmH₂O (mediana) Pas: 7.7cmH₂O

IAH: 1,9 e/h

m. de uso: 6h59 Bem adaptada

Natasha

10/05/24 Trocamos aparelho p/ Resmed
fixo pressão 5,8cmH₂O

m. de uso: 5h32m

Natasha

22/05
24

P = 5.8 cm H₂O
IAH = 1.0 e/h
m. de uso: 6h 59m
fuga: 12.8 lpm

Bem adaptada

Natasha

23/05
24

P = 5.8 cm H₂O
IAH = 0.6
m. de uso: 6h 22'
Fuga = 8.4 lpm

Melhorou a consciência,
a disposição durante o
dia.
fua cláudia

05/06
24

P = 5.8 cm H₂O
IAH = 2.0 e/h
m. de uso: 7h 5m
fuga: 11.9 lpm (percentil)

Relata não estar sentindo
tanta diferença durante
o dia

Natasha

10/06
24

P = 5.8 cm H₂O
IAH = 2.0 e/h
m. de uso: 6h 39'
Fuga = 5.5 lpm

Relata melhora p/ cami-
nhar.
fua.

26/06
24

P = 5.8 cm H₂O
IAH = 4.1 e/h
m. de uso: 6h 40'
Fuga = 9.9 lpm.

fua.

24/07
24

P = 5.4 cm H₂O
m. de uso: 6h 49'
IAH = 2.9 e/h
Fuga = 10.3 lpm.

Fazendo pilates (3x)
Oriente 15' caminhada.
fua.

04/09
24

P = 5.4 cm H₂O
IAH = 6.2 e/h
m. de uso: 5h 26'
Fuga = 3.6 lpm

Pilates (2x).
Troco o filtro
fua

13/11
24

P = 5.4 cm H₂O
m. de uso: 6h 20'
IAH = 2.3 e/h
fuga = 6.9

Tomando Canabidiol
fua.

16/01
25

P = 5.4 cm H₂O
IAH = 1.2 e/h
m. de uso: 5h 40'
fuga = 26.7 lpm

Bem adapt., "acrescenta que
se colocar umid. no max p^o
fluxo." Oriente

fua.

Nome: JURACI ALVES DOS SANTOS

Data de Nascimento: 16-8-1947

IMC: 30,18

Sexo: Masculino

Data do exame: 12-03-2024

Peso: 67 kg

Altura: 1,49 m

Médico: DR. MARIO SERGIO LEONE

CARREGOSA

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 12-03-2024, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 478,0 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 224,5 e 163,0 minutos. O tempo total de sono foi de 148,0 min, eficiência de 31,0% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 3,7%; estágio N2: 61,8%; estágio N3: 10,8%; sono REM: 23,6%. O índice de despertares foi de 17,6/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 76,2/hora, sendo 31 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 44 hipopnéias. A SpO2 média foi de 89% e a mínima de 71%, permanecendo 18,5% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 49 - 89 bpm e NREM de 46 - 72 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (06), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

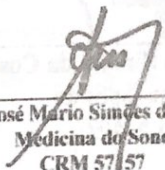
1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do estágio N3 do sono NREM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 76,2/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=71%);
5. latências para o sono prolongadas;
6. aumento do número de despertares breves;
7. registro de ronco durante o sono.

Pacientes desistiu do exame com CPAP

Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono e dessaturação de graus acentuados.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57/57

Nome: JURACI ALVES SANTOS
Data de Nascimento: 16-8-1947
IMC: 30,18
Sexo: F
Data do exame: 28-01-2024

Peso: 87 kg
Altura: 1,49 m
Médico: DR. GLAUCO FERNANDES DE SÁ
Medicamentos:
Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 28-01-2024, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 246,5 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 2,5 e 112,0 minutos. O tempo total de sono foi de 151,0 min, eficiência de 61,3% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 5,0%; estágio N2: 64,6%; estágio N3: 7,3%; sono REM: 23,2%. O índice de despertares foi de 31,6/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 70,7/hora, sendo 1 obstrutiva, 0 mistas e 0 centrais e 177 hipopnéias. A SpO2 média foi de 89% e a mínima de 68%, permanecendo 33,9% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 48 - 91 bpm e NREM de 48 - 74 bpm.

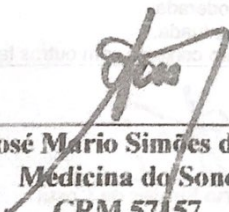
CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (6), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do estágio N3 do sono NREM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 70,7/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=68%);
5. latências para o sono normais;
6. aumento do número de despertares breves;
7. registro de ronco durante o sono.

Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono e dessaturação de graus acentuados.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157